



### RESUME MEDIS PASIEN

1. **Nama** : An. Tsamara Alicia Kinanthi
2. **Tanggal Lahir** : 11 April 2020
3. **Alamat** : Krajan 003/002 Klampok Singosari Malang
4. **Jenis Kelamin** : Perempuan
5. **Keadaan Pasien Awal Masuk** :

**S** : Pasien cenderung mengantuk dan tidur. Pasien juga mengeluh nyeri pada kedua kaki. Terdapat luka terbuka telapak kaki kiri dengan perdarahan aktif sehingga kedua kaki sulit digerakkan, serta luka babras pada tangan dan kaki

**O** : KU : lemah, GCS 356  
TD : 80/palpasi  
N : 172x/m  
RR : 30  
S : 36,3  
SpO2 : 96% NC 3 lpm

**Diagnosa** : 1. Syok Hipovolemik  
2. CF Femur Dextra Sinistra  
3. Crush Injury reg. pedis S

**Tindakan/Pertolongan yang Telah Diberikan** : - Head up 30  
- O2 NRBM 10-15 lpm  
- Loading RL 750cc → 20 tpm → lanjut drip Norepinefrin  
- Rawat luka, bebat tekan dgn kassa steril  
- Inj IV metamizole 300mg  
- Inj IV asam tranexamat 250mg → active bleeding (+) → drip adona dalam RL 500cc  
- Inj IM tetagam  
- Pasang bidai pada kedua extremitas bawah  
- Pasien dirujuk ke RSUD dr. Soetomo untuk tatalaksana lebih lanjut

:

:



### RESUME MEDIS PASIEN

1. Nama : Tn. Agus Effendi  
2. Usia : 30 Tahun  
3. Jenis kelamin : Laki-Laki  
4. Alamat : Krajan 003/002 Klampok Singosari Malang  
5. Keadaan Pasien Awal Masuk :

**S** : Pasien datang dengan nyeri di paha kiri dan lengan post KLL, nyeri dirasakan post KLL, dan tidak bisa digerakkan, luka terbuka (+), bengkak (+), perdarahan (+), pusing (+), mual (+), muntah (-), mimisan (-), keluar darah dari telinga (-), pingsan (-), kejang (-), pasien sadar dan ingat kejadian

**O** : KU : Lemah, GCS 456  
TD : 130/80 mmhg  
N : 122 x/menit  
RR : 20 x/menit  
Tax : 35.9°C  
Spo2 : 96% RA

**Diagnosa** : 1. CKR 456  
2. Syok Hipovolemi  
3. Susp. Fr. Femur sin  
4. CF. radius ulna sin  
5. CF Tibia fibula sin  
6. Susp. Dislokasi ankle  
7. Multiple V. Apertum  
8. Multiple V. Abrasio

**Tindakan/Pertolongan yang Telah Diberikan** : - Head Up 30°  
- Rawat luka : tutup kassa steril  
- O2 NRBM 10-15 lpm  
- Loading RL 2000cc  
- Pasang Bidai  
- IVFD RL 30 tpm  
- drip adona dalam RL  
- drip tramadol dalam Ns 100cc  
- Iv Ketorolac 30mg  
- Iv Ranitidin 50mg  
- Pasang Monitor, Dc  
- Rujuk di RSUD dr. Soetomo untuk tatalaksana lebih lanjut



### RESUME MEDIS PASIEN

1. Nama : Tn. Diki Wahyu Setiawan
2. Usia : 22 Tahun
3. Jenis kelamin : Laki laki
4. Alamat : Malang
5. Keadaan Awal Masuk :

**S** : Nyeri di kepala belakang dengan luka terbuka

**O** : KU cukup, GCS 456, Tanda vital stabil

**Diagnosa** :  
1. CKR 456  
2. Vulnus appertum regio -parietalis  
3. Multiple vulnus abratio

**Tindakan/Pertolongan yang Telah Diberikan** :  
- Inf RL 20 tpm  
- Inj piracetam 3gr  
- Inj Ranitidin 50mg  
- Inj Ondansetron 4 mg  
- Hecting  
- Debridement necrotomy

**Kondisi Terakhir** :  
- Keluhan nyeri berkurang  
- KU lemah, GCS 456  
- TD 119/66  
- N 60  
- RR 20  
- S 36.6  
- SpO2 98



### RESUME MEDIS PASIEN

1. Nama : Tn. Arif Dwi Efendi
2. Usia : 30 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Alamat : Jl. Raya Klampok
5. Keadaan Awal Masuk :

**S** : Nyeri di tulang kering dan pergelangan kaki kanan sehingga sulit digerakkan. Terdapat babras di kaki dan tangan

**O** : KU cukup, GCS 456, Tanda Vital stabil

**Diagnosa** :  
1. Susp dislokasi ankle D  
2. Muscle sprain  
3. Multiple vulnus abratio  
4. CKR 456

**Tindakan/Pertolongan yang Telah Diberikan** :  
- Inf RL 20 tpm  
- Inj Ketorolac 30mg  
- Inj Ranitidin 50 mg  
- Rawat luka

**Kondisi Tekini** :  
- KU cukup, GCS 456  
- TD 120/80  
- N 86  
- RR 20  
- S 36,8  
- Keluhan nyeri berkurang



### RESUME MEDIS PASIEN

1. Nama : Charles Nainggolan
2. Usia : 35 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Alamat : Sumatera Selatan
5. Keadaan Awal Masuk :

**S** : Nyeri di area pinggang post KLL hingga sulit berbaring. Keluhan disertai nyeri bahu kanan dan tangan kanan. Terdapat luka babras di tangan bahu dan pinggang

**O** : KU lemah, GCS 456, Tanda Vital stabil  
**Diagnosa** : 1. Muscle contusion  
2. Multiple vulnus abratio

**Tindakan/Pertolongan yang Telah Diberikan** :

- Inf RL 20 tpm
- Inj ketorolac 30mg
- Inj ranitidin 50mg
- Rawat luka
- Pasang arm sling

**Kondisi Terkini** :

- Keluhan pusing, nyeri tangan kanan
- KU cukup, GCS 456
- TD 120/80
- N 86
- RR 20
- S 36,7



### RESUME MEDIS PASIEN

1. **Nama** : Ny. Dhita Farikha
2. **Usia** : 28 Tahun
3. **Jenis Kelamin** : Perempuan
4. **Alamat** : Krajan 003/002 Klampok Singosari Malang
5. **Kondisi Awal Masuk** :
  - Pasien penurunan kesadaran. TTV tidak stabil. Terdapat multiple luka dan kaki kiri putus (vulnus amputatum)
  - Dilakukan Primary Survey dan tatalaksan awal, kemudian pasien cardiac arrest, dilakukan RJP. Pasien meninggal pukul 13.45 WIB
  - Pasien dirujuk ke RSSA untuk visum et repertum jenazah

Malang, 21 Maret 2024  
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah